EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	66932
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2023-07-05 09:19:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA ISABEL MALDONADO QUIROZ			RUN	: 7.838.670-3
F.Nac	: 20-11-1956	Edad	: 66 AÑOS, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-07-03	Fecha Egreso	: 2023-07-05 09:19:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

AM: HTA, DM TIPO 2 IR, OBESIDAD, DLP, ERC E 4, ICC, AC X FA
AQ: COLECISTECTOMIA, OP CATARATA OD ALERGIA
MEDICAMENTOS: METAMIZOL MEDICAMENTOS: I.NPH 44 UDS AM , PRADAXA 150 MG C/12 HORAS, DILTIAZEM 60 MG 1 C/12 HORAS, BISOPROLOL 2,5 MG 1 C/12 HORAS, LEVOTIROXINA 100 UGRS 1 COMPR/DIA, LOSARTAN 50 MG 1 COMPR C/12 HORAS

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15-NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. N18.3-ENFERMEDAD RENAL CRONICA,ESTADIO 3 (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE C/ANTEC DE DM TIPO 2 IR, HTA, ERC E3, QUE EL29/06/23 CONSULTA EN S.U. HSC POR PRESENTAR DESDE 3 SEMANAS ATRÁS, TOS POR LO QUE SE TRATÓ C/AMOXICLAVULANICO EN CONSULTORIO PERO PERSISTE IGUAL Y SE AGREGA DISNEA Y OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL, SE LE REALIZAN EXAMENES Y SE DG BNM Y SE LE INDICA TTO C/ LEVOFLOXACINA 500 MGS: 1/DIA, PDN 20 MGS: 1 C/12 HRS, CLORFENAMINA 4 MG 1 C/8 HORAS, B. IPRATROPIO INH Y BROMPIN JBE. EL 30/06/23 EN LA MAÑANA CONSULTA POR CEFALEA Y CIFRAS TENSIONALES ELEVADAS . SE LE INDICA KETOPROFENO Y SE DA DE ALTA. EL 30/06/23 EN LA TARDE VUELVE A CONSULTAR EN S.U. POR PERSISTENCIA CEFALEA, ALZA DE PRESION EN DOMICILIO 190/140 Y EN TRIAGE LE ENCUENTRAN HGT DE 469 POR LO QUE SE LE INDICA INSULINA CRISTALINA Y SE LE TOMAN EXAMENES ELP NA 135, /K 5,3 Y CL 106, G.BLANCOS 14800 C/SEG 79% Y TROPONINA 100.6, GSA: pH 7.37 pO2 70 pCO2 37 FIO2 21% PaFi= 333 mmHg, ECG RITMO SINUSAL SIN SIGNOS DE ISQUEMIA, SE PLANTEA CUADRO INFECCIOSO + HIPERGLICEMIA POR USO DE CORTICOIDES E ICC DESCOMPENSADA POR LO QUE SE HOSPITALIZA, SE INICIA TRATAMIENTO ANTIBIOTICO CON BUENA RESPUESTA DE PARAMETROS INFLAMATORIOS HE INFECCIOSOS, CON DETERIORO LEVE DE FUNCION RENAL POR LO QUE SE DECIDE SUSPENDER FUROSEMIDA Y INICAR HIDRATACION CONSERVADORA. EVOLUCIONA CON FAVORABLE RESPUESTA FUNCION RENAL Y CLINICA, POR LO QUE SE DECIDE ALTA VIA HODOM Y CONTROL POLI MEDICINA EN 15 DIAS PARA AJUSTE TRATAMIENTO CRONICO.

INDICACIONES AL ALTA

1. HOSPITALIZACION HODOM
2. REPOSO RELATIVO
3. REGIMEN DIABETICO- HIPOSODICO ESTRICTO C/RESTRICCIÓN HIDRICA 1500 CC DIA
4. OMEPRAZOL 20 MGS 1 COMPRIMIDO/NOCHE VO
5. CEFTRIAXONA 1 GR 2 FRASCOS/DIA EV POR 2 DIAS
6. BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF C/6 HORAS CON AEROCAMARA
7. SALBUTAMOL 3 PUFF CON AEROCAMARA CADA 8 HRS
8. INSULINA NPH: 44 UI SC (AM)
9. BISOPROLOL 2,5 MG 1 COMPRIMIDO C/12 HORAS VO
10. LEVOTIROXINA 100 UGRS 1 COMPRIMIDO/DIA VO
11. HIDRALAZINA 50 MG ½ COMPRIMIDO C/8 HORAS VO
12. CONTROL DE EXAMENES 07/07/23
13. CONTROL POLI MEDICINA EN 15 DIAS

EXÁMENES Y RESULTADOS

Laboratorio 05/07
Crea 2,1
VFG 23.56

Uremia 87
Na/K/Cl 139/4.5/105

CAMILA COLLAO ITURRA
MEDICO TRATANTE
19088566-6

JEFE SERVICIO